



CHĂM SÓC VÀ DỰ PHÒNG BỆNH RĂNG MIỆNG

ThS.BS. Nguyễn Quỳnh Hương
huongnq@pnt.edu.vn

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, sinh viên Y5 có khả năng:

- Chăm sóc răng miệng cho bản thân và những người xung quanh
- Trình bày được các nguyên tắc, biện pháp dự phòng và kiểm soát bệnh sâu răng
- Trình bày được các nguyên tắc, biện pháp dự phòng và kiểm soát bệnh nha chu
- Trình bày được các nguyên tắc, biện pháp dự phòng và kiểm soát bệnh ung thư hốc miệng

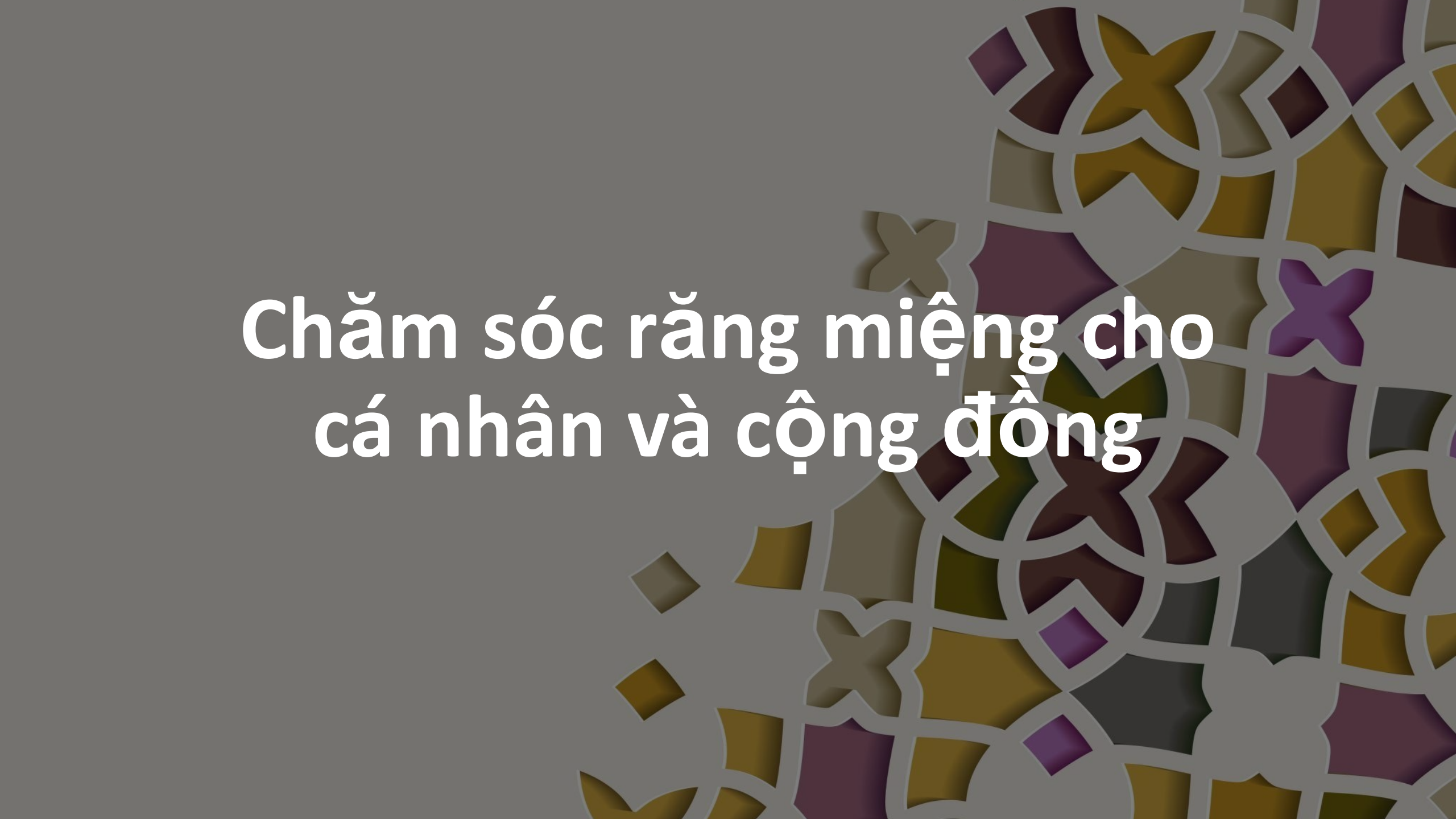
Nội dung

Chăm sóc răng miệng cho cá nhân và cộng đồng: sử dụng Fluoride, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh răng miệng, can thiệp

phòng ngừa
Dự phòng bệnh sâu răng

Dự phòng bệnh nha chu

Dự phòng bệnh ung thư hốc miệng



Chăm sóc răng miệng cho
cá nhân và cộng đồng

Sử dụng Fluoride

Fluor và sức khỏe răng miệng

- Fluor đường toàn thân
- Fluor dùng tại chỗ
- Fluor dùng chuyên nghiệp
- Fluor hóa nước máy

Fluor tại chỗ



1. Mọi nỗ lực phải được thực hiện để phát triển kem đánh răng florua giá cả phù hợp để mọi người đều có thể sử dụng. Là một biện pháp y tế công cộng, cần miễn thuế.
2. Mọi người nên được khuyến khích đánh răng hàng ngày bằng kem đánh răng florua. Tần suất đánh răng có liên quan tích cực đến phòng ngừa bệnh sâu R.
3. Hiệu quả phòng ngừa caries của kem đánh răng F có liên quan tích cực đến nồng độ F trong kem đánh răng.
4. Trẻ em dưới 6 tuổi, đánh răng nên được giám sát và chỉ cần một lượng rất nhỏ (có kích thước nhỏ hơn 5 mm, 'hạt đậu'). Không nên sử dụng kem đánh răng có hương vị thơm, ngọt như kẹo hoặc có chứa F ở 1500 ppm trở lên bởi trẻ em dưới 6 tuổi có thể nuốt.
5. Chương trình chải R với kem có florua tại trường học để vệ sinh RM nên được khuyến khích thực hiện.
6. Cần thêm các nghiên cứu về tác dụng của kem đánh răng F chống sâu chân R ở người lớn tuổi

Fluor dùng chuyên nghiệp

- Viên F bổ sung: áp dụng hạn chế trong y tế công cộng
- Trong các khu vực có tình trạng sâu răng sữa và vĩnh viễn cao, cần cân nhắc liều lượng F uống bổ sung với tổng số nguồn F từ nước và các nguồn khác, cùng với sự phổ biến của fluorosis trong cộng đồng.
- Để tránh trẻ em tự uong gây ngộ độc: viên bổ sung nên được chứa trong các thùng chứa tránh trẻ em. Số lượng natri F trong tất cả các viên thuốc trong hộp không vượt quá 120mg

The background features two large, decorative, curved lines. One line, in shades of blue and green, curves from the top right towards the center. Another line, in shades of green and blue, curves from the bottom left towards the center. The text is centered between these two curves.

Chế độ dinh dưỡng

Chế độ ăn và Sâu răng

- Chế độ ăn: quan trọng cho phòng bệnh và trị bệnh. Ảnh hưởng sức khỏe chung của con người.
- Dự phòng sâu răng qua kiểm soát chế độ ăn
- Thức ăn có tác động tại chỗ ở môi trường miệng, và đi vào máu sau đó quay lại nuôi các mô miệng.
- Chế độ ăn có chứa Carbohydrates gây sâu răng do tạo acid trên bề mặt răng.

-
- Chế độ ăn: loại và lượng thức ăn hằng ngày (FDI, 1994), tác động tại chỗ của thực phẩm lên vùng miệng, liên quan thành phần thức ăn và tần suất ăn, đề cập tác dụng tại chỗ.
 - Dinh dưỡng: liên quan đến tổng lượng, tỉ lệ thành phần của thức ăn, liên quan quá trình hấp thu và chuyển hóa, đề cập tác dụng hệ thống
 - Đặc thù răng miệng thì quan tâm đến chế độ ăn.
 - Chế độ ăn không quan trọng nhiều hay ít, mà quan trọng ở cân bằng.

-
- Phân loại thức ăn: nguồn gốc động vật, thực vật/ chứa protein, vitamin, khoáng / chức năng: tạo mô cơ thể như sữa, cung cấp năng lượng như đường, thực phẩm bảo vệ như vitamin/ theo năng lượng
 - Tháp dinh dưỡng hướng dẫn cân bằng dinh dưỡng, ở đáy tháp thì sử dụng nhiều, lên cao thì ít hơn, phải đầy đủ các thành phần
 - Cân bằng: đầy đủ, không quá mức
 - Chế độ ăn liên quan Bệnh căn của Sâu răng (Sơ đồ Key)
 - Men răng khỏe mạnh: nhờ thành phần acid liên quan chế độ ăn

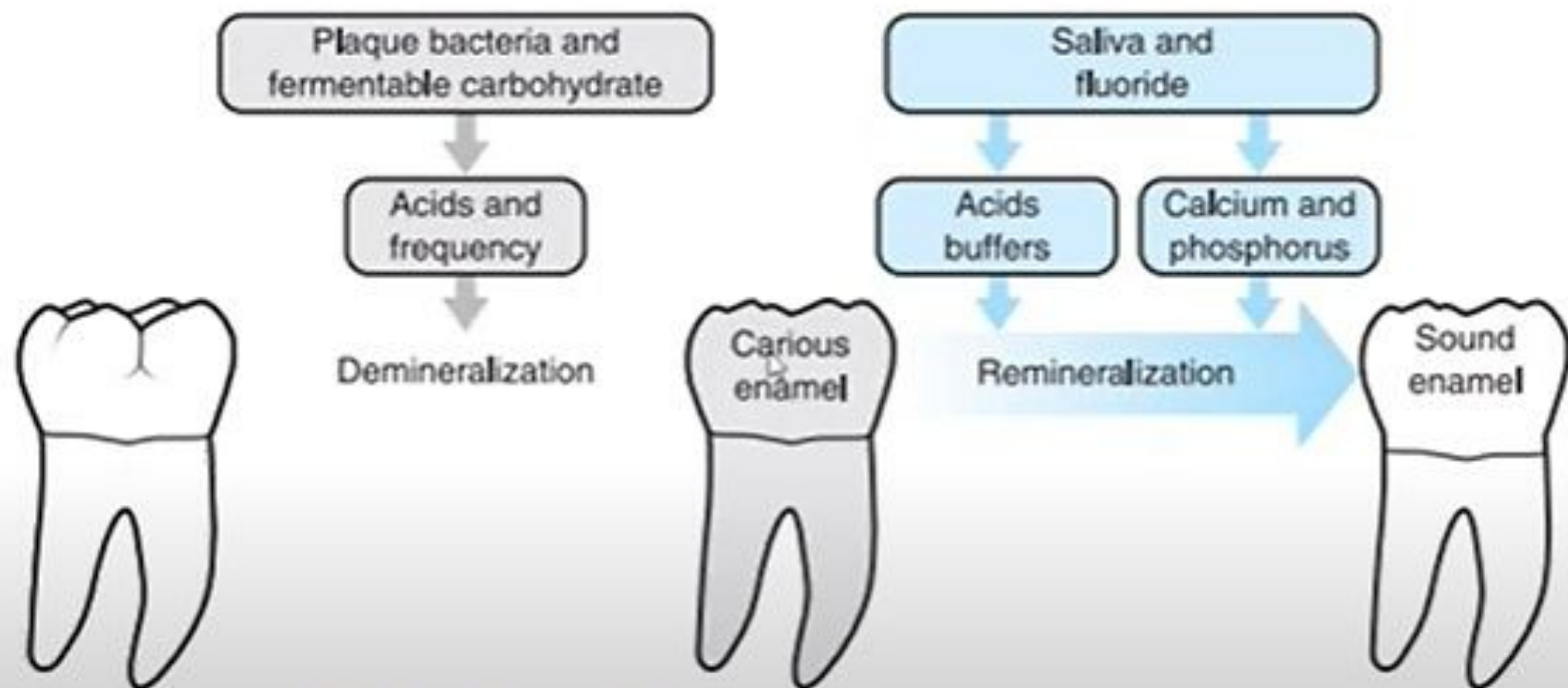


FIGURE 9-1 Dental caries equation.

Yếu tố quyết định tính gây sâu răng của chế độ ăn:

- Tính chất vật lý của thức ăn: thức ăn lỏng dễ thanh thải trong khoang miệng (nước ngọt > kẹo dính)
- Tần suất ăn: ăn vặt => ăn nhiều lần => cơ hội vi khuẩn lên men, thường gặp ở trẻ em
- Trình tự của thực phẩm tiêu thụ trong bữa ăn: ăn đường trước hay sau
- Chất béo và Protein trong bữa ăn: tạo lớp bao phủ bảo vệ chất đường được ăn sau đó=> nên ăn ngọt sau cùng
- Sản phẩm từ sữa: giàu hàm lượng Canxi và Phospho giúp cho tái khoáng
- Ăn phomai sau khi ăn đường giúp ngăn ngừa sự giảm pH xuống dưới 5.5

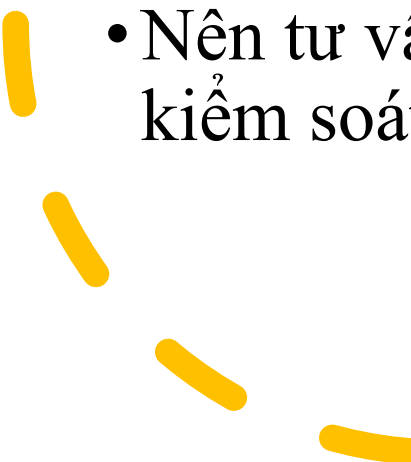
- Trong các loại đường: đường sucrose gây sâu răng cao, tinh bột gây sâu răng thấp nhất, đường tự nhiên như mật ong vẫn gây sâu răng như đường tinh luyện
- Thức ăn có chứa hàm lượng Sucrose ít hay nhiều đều gây sâu răng
- Fluor, Nước bọt giúp bảo vệ men răng
- Thực phẩm giúp làm ngưng sâu răng: chất béo không làm giảm pH của khoang miệng mà còn làm tăng pH sau khi dùng carbohydrate; protein làm tăng urea nước bọt, giúp đệm acid, nên ăn trước đường; phosphates cũng giúp đệm acid; fluoride giúp kháng khuẩn, chống hình thành mảng bám
- Thay thế đường: đường tổng hợp (synthetic sweeteners) như saccharine, aspartame, hay đường alcohols (sugar alcohols) như xylitol, mannitol, lactitol, isotitol, erythritol. Vi khuẩn trong mảng bám không chuyển hóa được, và chất Xylitol còn giảm vi khuẩn gây sâu răng



- Nước giải khát có chứa gas:

- + Uống bằng ống hút, hoặc dùng trong bữa ăn sẽ giúp giảm mất khoáng men răng

- + Nên súc miệng với nước sau khi uống nước ngọt



- Nên tư vấn giáo dục giúp BN thay đổi chế độ ăn, giúp tăng hiệu quả kiểm soát bệnh lý: thứ tự ăn, đường thay thế, cách dùng nước giải khát

Chế độ ăn và Bệnh nha chu

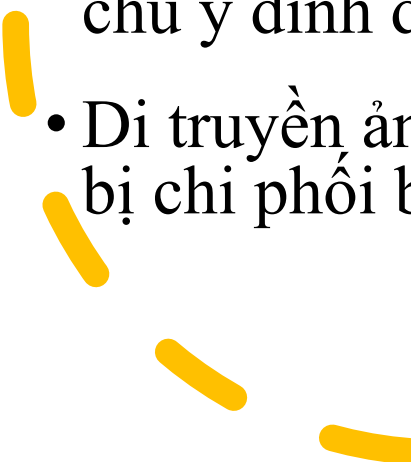
- Phức tạp
- Do đa nguyên nhân: mức sống, chủng tộc, dân trí, mật độ xương, tiểu đường, hút thuốc, thói quen thăm khám nha sĩ..
- Nghiên cứu cho thấy thiếu các thành phần quan trọng liên quan đến sức khỏe: vitamin A, C, D, Calcium, Protein, phức hợp Carbohydrate trong chế độ ăn.
- Vi khuẩn, đáp ứng miễn dịch là bệnh căn
- Mà đáp ứng miễn dịch thì liên quan dinh dưỡng
- Hay nói cách khác, vi khuẩn là giống nhau, nhưng tình trạng bệnh nha chu khác nhau
- Chế độ ăn quan trọng trong tiến triển bệnh nha chu

-
- Sang thương của bệnh nha chu cũng giống như một vết thương, quá trình lành thương phụ thuộc vào đáp ứng của ký chủ, quá trình lành thương phụ thuộc dinh dưỡng của bệnh nhân: “dinh dưỡng trị liệu”.
 - Người sử dụng Carbohydrate nhiều thì dễ viêm nướu hơn
 - Chế độ ăn nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa, dầu cá, ít đường tinh luyện thì giảm viêm
 - Việc thay đổi chế độ ăn ảnh hưởng kiểm soát bệnh nha chu
 - Dinh dưỡng có ảnh hưởng đến di truyền, qua đó ảnh hưởng lại bệnh nha chu: nutrigenomic, thay đổi mức độ biểu hiện gen



Vai trò dinh dưỡng trong điều trị bệnh nha chu: do bệnh căn đa yếu tố, cần lưu ý khi tư vấn cho bn

- Đánh giá chế độ ăn : mô tả phương pháp chế độ thức ăn, đánh giá theo phân loại nhóm thực phẩm (ngũ cốc, rau củ, sữa, thịt cá)
 - Giải thích mối tương quan dinh dưỡng và nha chu: giảm đường, thay thế thức ăn ngọt bằng thực phẩm nhiều xơ, giàu dinh dưỡng, giúp tạo mô nha chu khỏe mạnh, chú ý trong chế độ ăn phải đa dạng, đầy đủ , cân bằng
 - Tìm hiểu bệnh sử từ quá trình chế độ ăn trước đây: thực phẩm bn không thích ăn có thể lại cần cho cơ thể.
 - Chẩn đoán vấn đề dinh dưỡng của bn
 - Tư vấn bn cần tăng cường thành phần nào trong chế độ ăn. Hiệp hội nha chu khuyến cáo: tăng dầu cá, rau củ chất xơ, sữa
 - Theo dõi bn
- 
- 
- 
- 

- 
- Chế độ ăn khi có phẫu thuật nha chu: bn phải trải qua 01 stress, dinh dưỡng cho bn phải giúp trải qua dc phẫu thuật và lành thương tối ưu nếu có dinh dưỡng tốt: tăng cường chế độ ăn thì protein phải đủ 120gr / ngày, vitamin, bổ sung thức uống, bánh dinh dưỡng
 - Kết luận: giúp đề kháng nhiễm trùng, tăng cường và duy trì hàng rào biểu mô ngăn chặn tác nhân gây bệnh và tấn công, cải thiện quá trình lành thương của những mô nha chu bị tổn thương, nếu có bệnh lý xảy ra thì giúp mau hồi phục, cần có tư vấn và hướng dẫn về mặt dinh dưỡng đối với trường hợp cần dự phòng nha chu thì cần có dinh dưỡng phù hợp. Trước đây điều trị bệnh hầu như chưa chú ý dinh dưỡng, điều chỉnh bổ sung gì để kiểm soát bệnh nha chu
 - Di truyền ảnh hưởng lên cơ chế đáp ứng của bệnh nha chu nhưng cũng di truyền bị chi phối bởi dinh dưỡng
- 



Vệ sinh răng
miệng

- Biện pháp vệ sinh răng miệng cơ học:
- Biện pháp vệ sinh răng miệng hóa học:

TOOTHBRUSH

THE CORRECT USE

Clean teeth and healthy gums.

CURAPROX



CURAPROX

ORAL CARE WITH BRACES

THE CORRECT USE

Brush teeth, even with braces.







Can thiệp phòng
ngừa

Trám bít hố rãnh

- -Vai trò và ý nghĩa của trám bít hố rãnh phòng ngừa sâu răng trong nha khoa dự phòng
- Trám bít hố rãnh là một trong những biện pháp dự phòng quan trọng trong dự phòng sâu răng. Biện pháp này luôn kết hợp với giáo dục sức khỏe răng miệng, vệ sinh răng miệng cá nhân hiệu quả, dùng Fluor.
- Áp dụng cho răng sữa và răng vĩnh viễn
- Áp dụng cho trẻ em và người lớn
- Đơn giản dễ thực hiện
- Chi phí thấp, hiệu quả cao
- Áp dụng cho các chương trình nha khoa cộng đồng và nha khoa lâm sàng
- Bệnh nhân dễ chấp nhận.

Lịch sử

- 1905: trám bít hố rãnh với Silver Nitrate (Miller)
- 1923: Hyatt giới thiệu thuật ngữ “Prophylactic odontology”
- 1929: Bodecker trình bày nguyên lý bít rãnh răng
- 1955: Buonocore giới thiệu lưu vi ngàm mặt nhai bằng acid và bít hố rãnh với resin sealant
- 1965: Bowen phát triển BÍ-GMA resin
- 1970: thập niên 1980, 1990: Resin quang trùng hợp
- 2000's: resin phóng thích fluor

- Sealant là “lớp phủ bằng vật liệu” trên hố vĩa rãnh răng nhằm ngăn chặn sự tích tụ của các vi khuẩn sinh sâu răng
- Quy trình kỹ thuật không xâm lấn, thẩm mỹ và chi phí thấp
- Trám bít hố rãnh được thực hiện bởi nhà chuyên môn: y-bác sĩ RHM, Y sĩ RTE, Đ D Nha khoa

- Đánh giá để xác định người và răng cần trám bít hố rãnh:
- Đánh giá nguy cơ người và răng dễ bị sâu răng
- Đánh giá nguy cơ sâu răng gồm: sự tích tụ mảng bám, thức ăn-uống dễ sinh sâu răng, tiền sử sâu răng của cá nhân và gia đình, ít sử dụng Fluor, giải phẫu hình thái hố và rãnh răng.

- Những lưu ý khác:
- -Trám bít hố rãnh dự phòng sâu răng trên hố và rãnh chưa sâu răng
- -Răng có hố rãnh sâu (độ sâu) chia nhiều nhánh
- -Nếu có sâu răng ở mặt tiếp cận (lâm sàng hay xác định qua Xquang) KHÔNG trám bít hố rãnh.
- -Sâu tái phát trên hố và rãnh KHÔNG trám bít hố rãnh.
- Những tình huống trám bít hố và rãnh có thể thất bại:
- -Không hay rất khó cô lập và dễ vấy nhiễm
- -Răng sữa gần thời kỳ rụng răng sinh lý
- -Hố rãnh đã có lỗ sâu
- -Một vài trường hợp dị ứng với miếng trám bít sealant

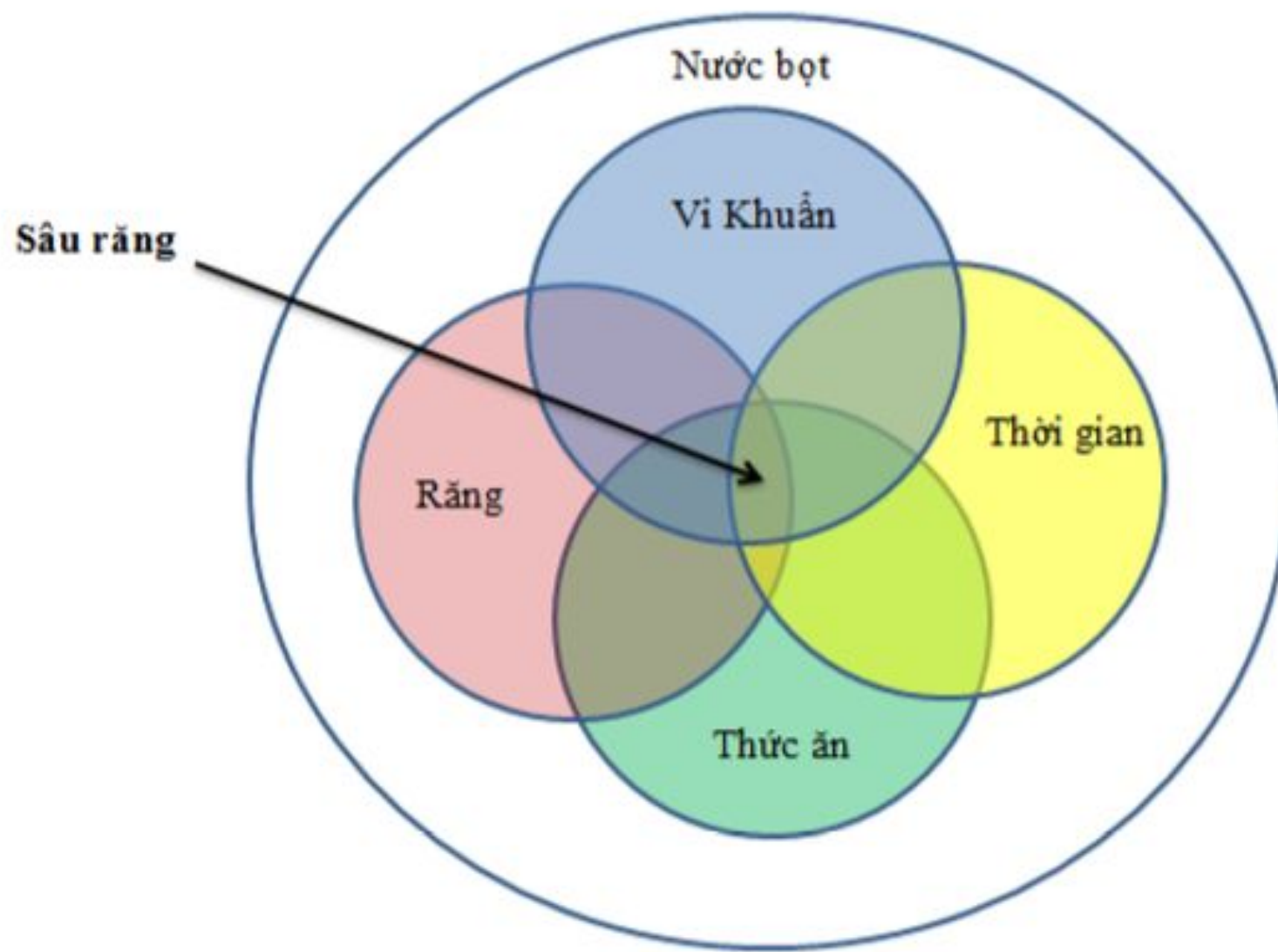
- Quy trình trám bít hố rãnh: truyền thống, không rửa

Quy trình truyền thống

- -Làm sạch mặt nhai bằng xịt hơi hay làm sạch bằng chổi với bột dự phòng
- -Lấy sạch mảnh vụn thức ăn ở hố và rãnh
- -Lưu vi ngấm trên men răng với acid (15 giây)
- -Rửa và thổi khô
- -Thổi khô vừa đến khi thấy những mảng và đốm trắng trên mặt răng, hố và rãnh
- -Đặt vật liệu trám bít lên hố và rãnh răng
- -Chiếu đèn theo thời gian hướng dẫn của nhà sản xuất. Miếng trám bít sẽ đổi màu trắng khi vật liệu hoàn toàn đông cứng.
- -Dùng giấy cắn để kiểm tra khớp cắn. Nếu có những điểm màu là có điểm “cộm”. Mài chỉnh điểm cộm. Đánh bóng nếu mài chỉnh khớp nhiều.



Dự phòng Bệnh sâu răng



Nguyên tắc chính dự phòng bệnh sâu răng

- **Giảm số lượng vi khuẩn**

- + Vệ sinh răng miệng: cơ học, hóa học

- **Giảm lượng Carbohydrate**

- + Kiểm soát thực phẩm: chất xơ, sữa và chế phẩm từ sữa

- + đưa bột đường vào các bữa ăn chính

- **Tăng cường sức đề kháng của răng:**

- + Fluor toàn thân hoặc tại chỗ

- + Cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho răng trong quá trình mọc răng cũng như tái khoáng hóa

- + Sealant trám bít hố rãnh

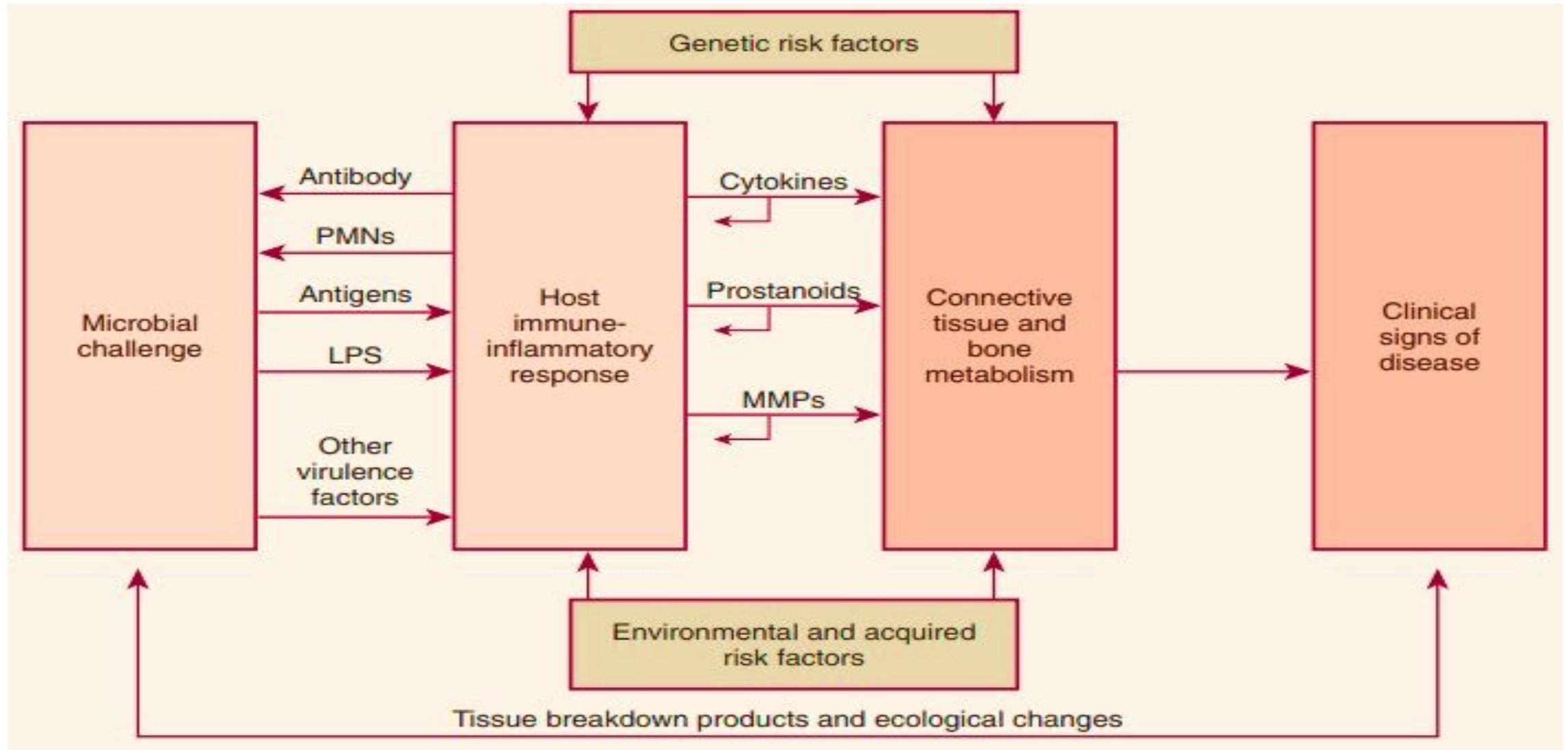
Các biện pháp dự phòng sâu răng

- Tuyên truyền vệ sinh răng miệng
- Vệ sinh răng miệng, kiểm soát mảng bám
- Kiểm soát thực phẩm: đường, chế độ ăn uống
- **Sử dụng Fluor:**
 - + Fluor hóa nước máy
 - + Viên Fluoride (khi $<0,3\text{ppm}$)
 - + Muối Fluoride
 - + Fluoride trong nước súc miệng
 - + Fluoride trong kem đánh răng
 - + Sealant trám bít hố rãnh

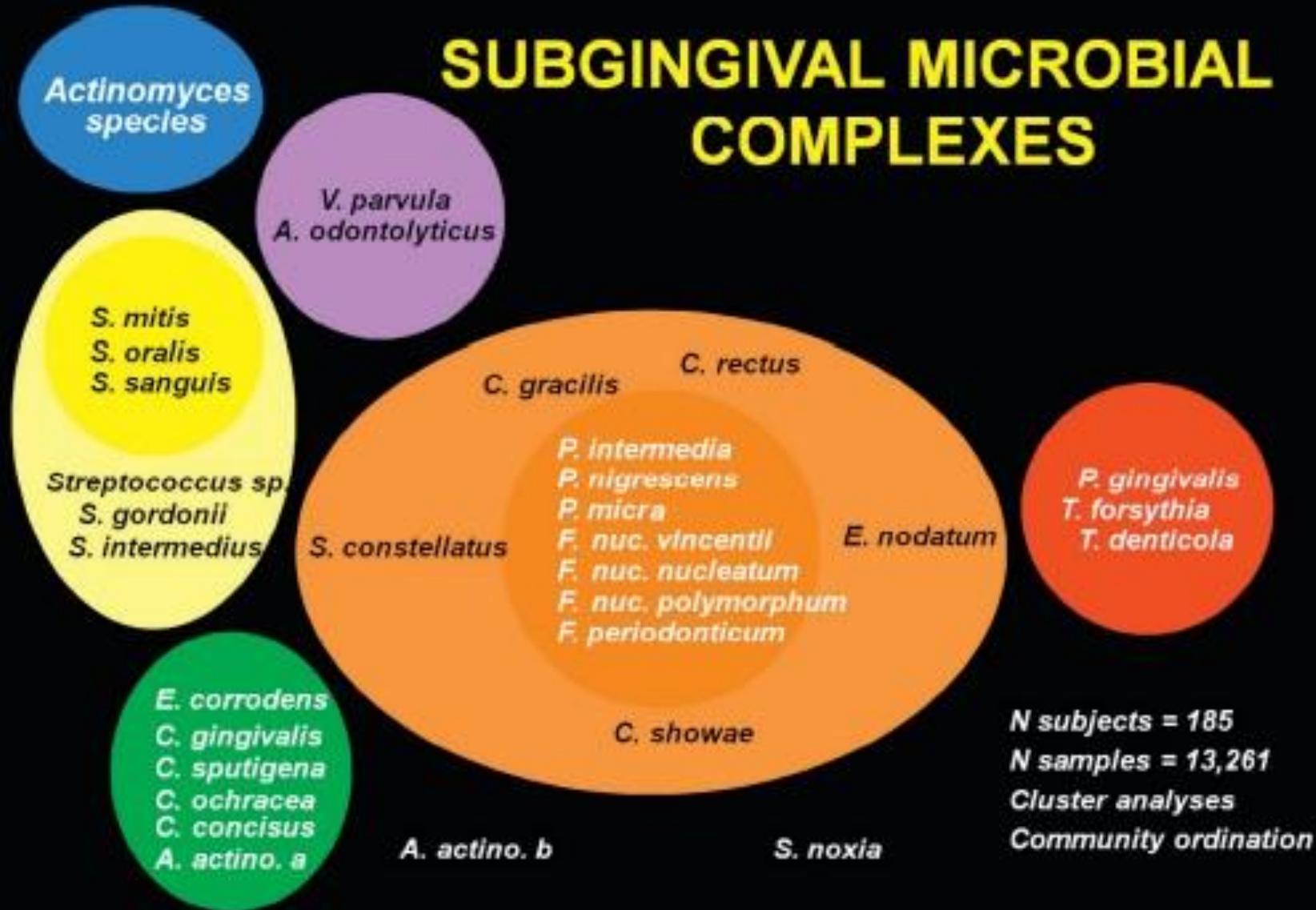
Dự phòng Bệnh nha chu

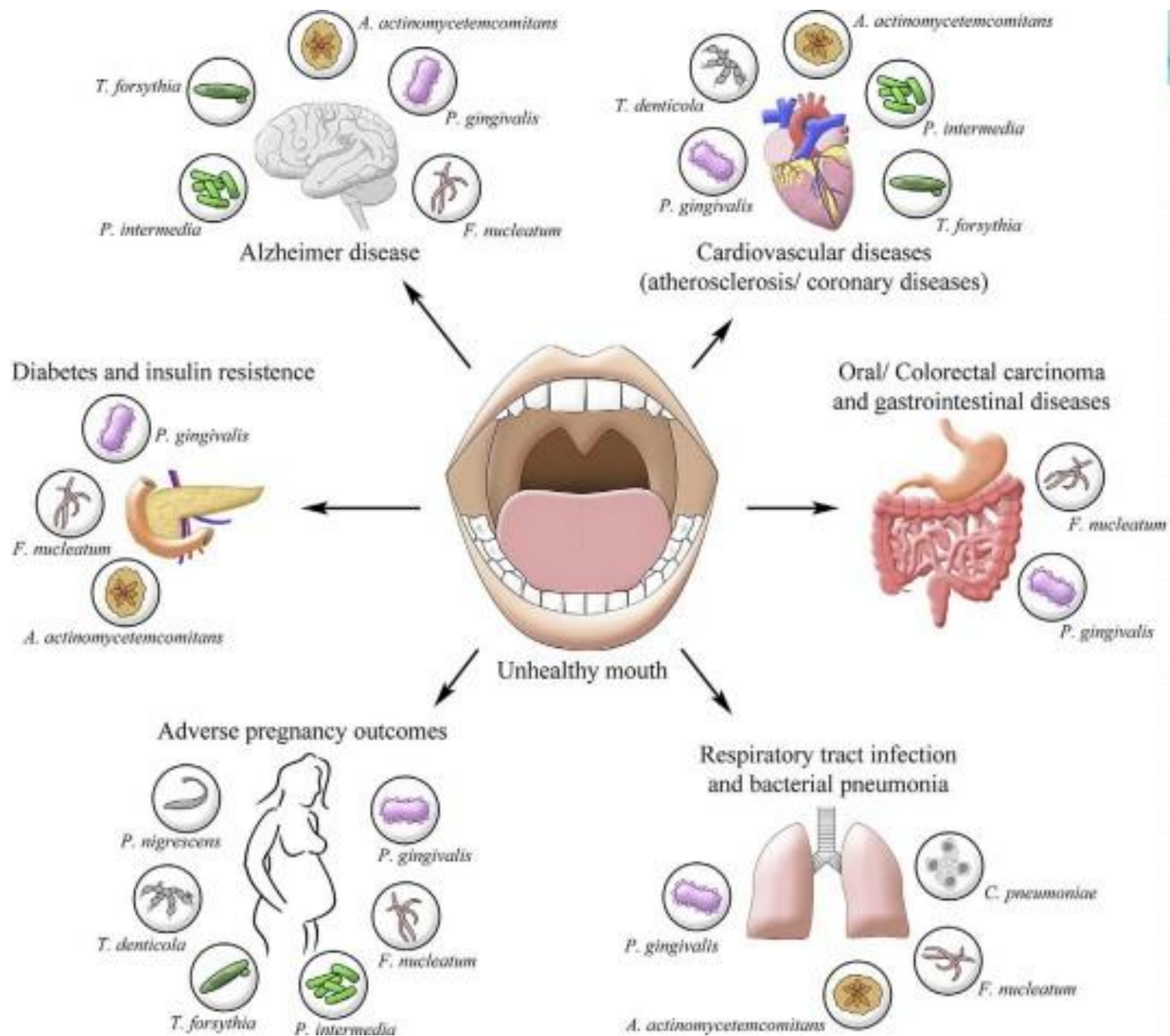
- Sức khỏe nha chu là một trong những yếu tố quan trọng của sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân. Nó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của từng cá nhân và cộng đồng.
- Nha chu viêm chiếm tỉ lệ >50% ở người trưởng thành trong đó 11% là ở các thể nặng và đứng thứ 6 trong tỷ lệ bệnh của con người.
- Bệnh nha chu là bệnh đa nguyên nhân từ yếu tố sinh học miệng, yếu tố toàn thân, yếu tố kinh tế -xã hội. Bệnh nha chu rất cần sự quan tâm đặc biệt của từng cá nhân, cộng đồng, xã hội, nhà chuyên môn và cấp lãnh đạo.
- Bệnh nha chu (viêm nướu & viêm nha chu) là một bệnh nhiễm khuẩn.
- Ngày nay viêm nha chu còn là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh toàn thân.
- Dự phòng và điều trị viêm nha chu sẽ kiểm soát tốt các bệnh toàn thân đi kèm.
- Điều trị viêm nha chu: điều trị cơ học + kháng khuẩn tại chỗ và / hoặc kháng sinh toàn thân.

Sinh bệnh học Viêm nha chu



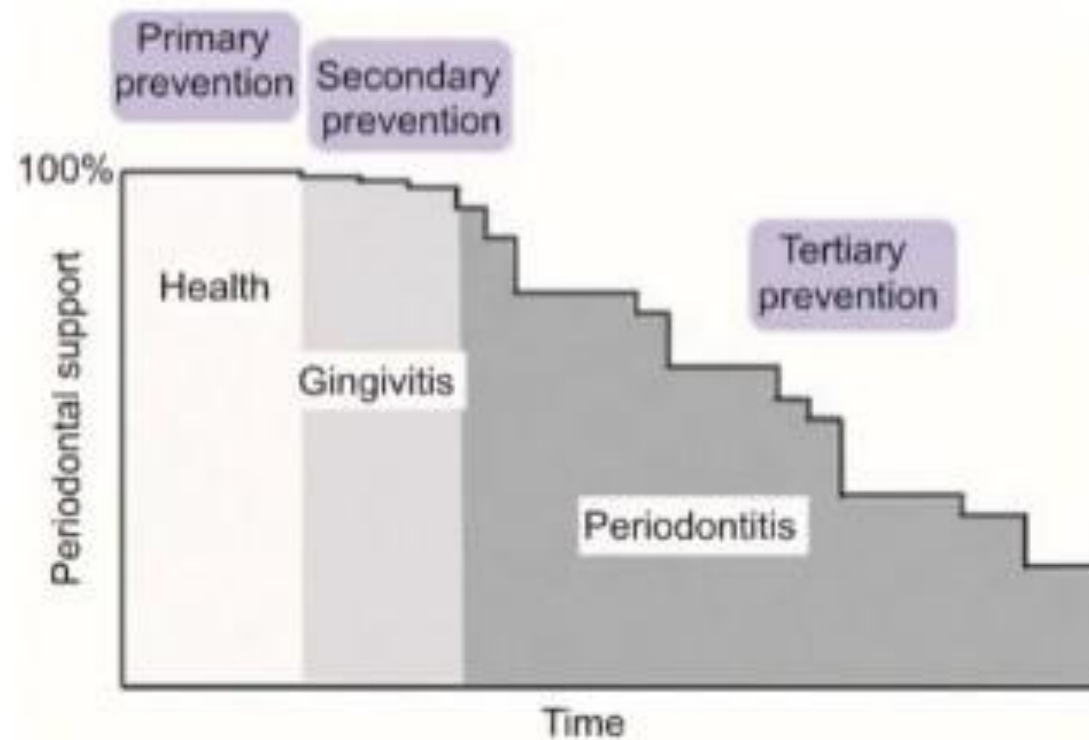
SUBGINGIVAL MICROBIAL COMPLEXES





Dự phòng bệnh nha chu

Dự phòng bệnh nha chu phải tác động đến nhiều yếu tố trong đó can thiệp dự phòng và kiểm soát bệnh trong từng giai đoạn với nhiều biện pháp khác nhau.



Mục đích dự phòng Bệnh nha chu

- Củng cố và nâng cao sức khỏe mô nha chu
- Phòng ngừa tổn thương mới khởi phát
- Can thiệp điều trị những tổn thương mô mềm và mô cứng để từ đó tái tạo sức khỏe mô nha chu và dự phòng các biến chứng tiếp diễn.

Cách tiếp cận trước đây:

- -Kết luận từ Hội thảo ở Châu Âu 1998 về kiểm soát cơ học mảng bám là “ loại trừ mảng bám răng là cách thức cơ bản để bảo vệ sức khỏe nha chu, sức khỏe răng miệng”
- -Cách tiếp cận dự phòng nha chu truyền thống là giáo dục sức khỏe răng miệng, hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh răng miệng đúng cách.
- -Người bệnh sẽ được giáo dục về nguyên nhân gây bệnh nha chu (ví dụ: mảng bám răng, kỹ năng cơ học để loại trừ mảng bám răng, ví dụ: vệ sinh răng miệng đúng cách.)
- -Cách can thiệp truyền thống là giáo dục một chiều, không đề cập đến các yếu tố kinh tế xã hội, yếu tố hành vi.

- Thực hành phòng ngừa: tạo cầu nối với bệnh nhân (Prevention in practice-forming a bridge to the patient)
- -Chiến lược phòng ngừa ở các cấp độ bệnh nhân phải được hiểu biết rộng rãi
- -Can thiệp dự phòng phải định hướng về những ảnh hưởng hành vi của bệnh nhân.

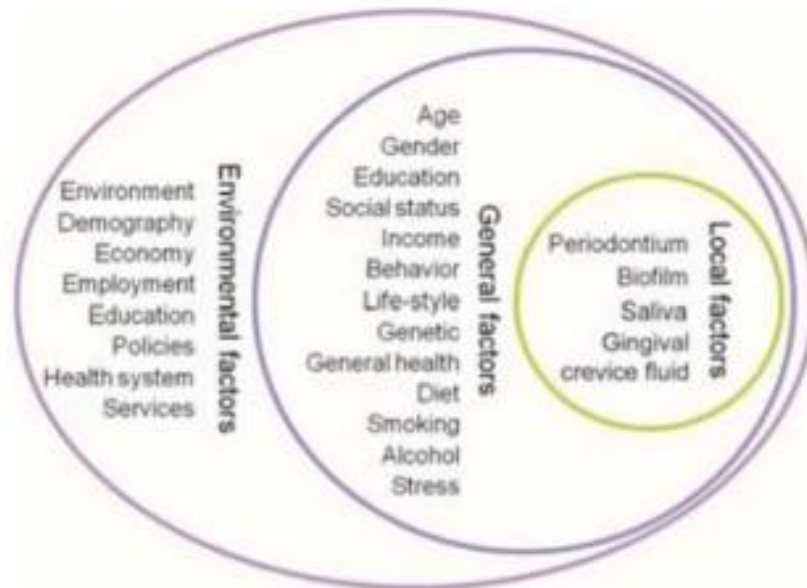


Fig. 2. Environmental, general and local risk factors linked to the development of periodontal disease.

Giao tiếp với người bệnh:

- -Người thầy thuốc có trách nhiệm giải thích, động viên, hướng dẫn người bệnh thực hiện những hành vi có lợi (dự phòng cấp 01), thay đổi cách sống, loại bỏ những hành vi không thích hợp (dự phòng cấp 2, 3).
- -Lấy phương châm “người bệnh là khách hàng, là trung tâm”, là đối tượng trực tiếp phục vụ, thay đổi cách chăm sóc người bệnh sao cho việc giải quyết bệnh và tinh thần người bệnh được thành công.
- -Đẩy mạnh công tác tham vấn với những biện pháp tham vấn với những biện pháp thích hợp và hiệu quả.

Chiến lược dự phòng:

- -Dự phòng có vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa xuất hiện bệnh, giảm mức độ trầm trọng của bệnh. Như vậy, chiến lược dự phòng là nhằm vào việc phòng ngừa bệnh tật hay sự tiến triển của bệnh.
- -Chiến lược dự phòng đóng vai trò rất quan trọng trong mọi phương thức điều trị bệnh nha chu. Chiến lược dự phòng bệnh nha chu bao gồm dự phòng cấp 1 và dự phòng cấp 2.

Levels of prevention:



Primary

Strategies designed to ensure that the disease or process fails to become clinically evident



secondary

Involves early recognition and treatment of the disease processes



tertiary

Involves disability limitation and rehabilitation. Supportive periodontal treatment could be considered a part of it

Levels of prevention:

	Primary		Secondary	Tertiary	
Levels of prevention	Health Promotion	Specific Protection	Early Diagnosis and Prompt Treatment	Disability Limitation	Rehabilitation
Services provided by the Individual	Periodic visits to dental office Demand for preventive services	Oral hygiene practices	Self examination and referral Utilization of dental services	Utilization of dental services	Utilization of dental services
Services provided by the community	Dental health education programs Promotion of research	Provision of oral hygiene aids, Supervised school brushing programs	Periodic Screening and referral Provision of dental services	Provision of dental services	Provision of dental services
Services provided by the dental professional	Patient education Recall reinforcement	Plaque control program Correction of mal-aligned teeth, Prophylaxis	Complete examination, Scaling and curettage, Corrective restorative and occlusal services	Deep curettage Root planing and splinting Periodontal surgery, Selective extractions	Removable or fixed partial dentures Minor tooth movement

- Dự phòng cấp 01: là tiến trình giúp mọi người gia tăng kiểm soát hành vi quá mức và cải thiện sức khỏe. Nó không can thiệp trực tiếp vào bệnh lý nhưng giúp người bệnh củng cố sức khỏe, tăng cường sự đề kháng chống bệnh tật.
- -Giáo dục sức khỏe răng miệng
- -Dinh dưỡng cân bằng và hợp lý
- -Thay đổi hành vi và cách sống.
- Giáo dục sức khỏe răng miệng :
- -Giáo dục sức khỏe răng miệng là nhằm thay đổi kiến thức-thái độ-hành vi của người bệnh và cộng đồng.

- -Giáo dục sức khỏe răng miệng là nội dung cơ bản của nha khoa dự phòng
- -Là kênh thông tin quan trọng từ người bệnh, cộng đồng đến sự phục vụ của Bác sĩ và các dịch vụ của các cơ sở y tế.
- -Giáo dục sức khỏe luôn phải thay đổi nhằm vào việc làm thay đổi hành vi. Tăng kiến thức, đổi thái độ, củng cố và hình thành những hành vi có lợi cho sức khỏe cực kỳ quan trọng.

Công cụ giáo dục:

Educational aids:



AUDITORY



VISUAL



AUDIO-VISUAL AIDS

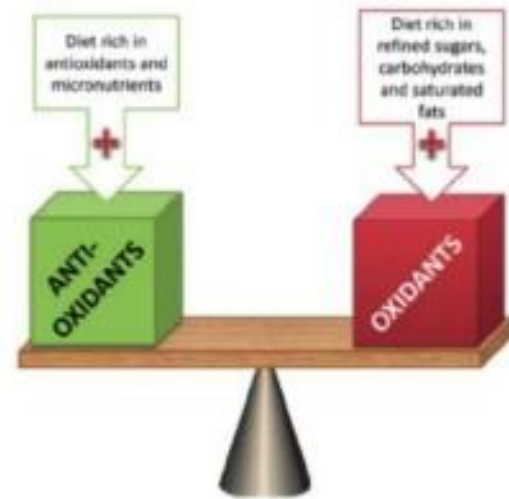
Phương pháp truyền thông sức khỏe:

- -Cá nhân: tiếp xúc cá nhân, đến tận nhà tư vấn (vãng gia), gửi thư cá nhân
- -Nhóm: bài nói, thuyết trình , thảo luận nhóm
- -Tiếp cận truyền thông: radio, television, posters, internet, printed material, direct mailing, posters, health museums and exhibitions and folk methods
- Tiếp cận truyền thông đại chúng: nên sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại như truyền thông mạng xã hội (social community, social publishing, social commerce, social entertainment) như Twitter, Instagram, Facebook, Google Plus...

Disclosing agent:

- Chất phát hiện mảng bám thường dùng cho các chương trình dự phòng bệnh răng miệng. Được sử dụng để đánh giá tình trạng vệ sinh răng miệng cá nhân, cộng đồng. Nó rất hữu ích cho việc cải thiện thực hành vệ sinh răng miệng (Nepale và cộng sự).

- Dự phòng cấp 01:
- -Người bệnh: thực hành vệ sinh răng miệng, thói quen, dinh dưỡng
- -Bác sĩ RHM: loại trừ mảng bám, giáo dục-động viên người bệnh
- Loại trừ mảng bám bằng biện pháp cơ học:
- -Sử dụng các phương tiện để loại trừ mảng bám răng
- -Cá nhân, cộng đồng ý thức và sử dụng đúng và thường xuyên các phương tiện để loại trừ mảng bám răng.
- chế độ dinh dưỡng



FOODS RICH IN ANTIOXIDANTS

- Broccoli
- Spinach
- Berries
- Beans (e.g. Kidney, black, pinto)
- Avocados
- Red wine
- Kiwi
- Dark (high cocoa) chocolate
- Artichoke

Diet recommendations of 2011 European workshop on Periodontology

- **Dự phòng cấp 02:**

- Bao gồm chẩn đoán sớm và điều trị sớm (early, prompt)
- Tái khám định kỳ
- Đánh giá nguy cơ, dự đoán khả năng tái phát
- Chẩn đoán sớm: 02 lĩnh vực của phòng ngừa là: phòng ngừa tái phát, phòng ngừa tiến triển, và có kết nối với nhau.

- Dấu hiệu và triệu chứng của bệnh:
- -Chảy máu dưới thẩm khám nhẹ nhàng bằng thám trâm, dự đoán 30% mất bám dính trong tương lai.
- Công cụ chẩn đoán: Xquang, thẩm khám gương -thám trâm
- Công cụ đánh giá nguy cơ:
- -Những cá nhân khác nhau cho thấy độ nhạy cảm khác nhau về khởi phát và tiến triển viêm nha chu.
- -Công cụ dự đoán dựa trên xếp nhóm bệnh nhân dựa vào yếu tố nguy cơ tùy theo mức độ nguy cơ khác nhau, tuy nhiên tiên lượng có thể không chính xác lắm

- **Dự phòng cấp 03:** hạn chế biến chứng và hồi phục
- -Điều trị nha chu nâng đỡ
- -Hạn chế biến chứng: giảm nhiễm khuẩn, giải quyết viêm, giảm lung lay răng, phòng ngừa mất răng.
- -Biện pháp chính: xử lý mặt gốc răng, nạo túi nha chu, nẹp răng
- -Phẫu thuật nướu niêm mạc: làm dài thân răng, tạo hình nướu, tạo hình xương, cắt xương, điều trị vùng chề chân răng,
- -Tái tạo: ghép xương, yếu tố tăng trưởng, proteins khuôn men
- -Nội nha
- -Nhổ răng có chọn lọc

- Tại sao người bệnh khó tuân thủ nguyên tắc: chủ quan với bệnh tình, sợ hãi khi điều trị, lo ngại tài chính.
- Phương pháp cải thiện sự tuân thủ nguyên tắc: đơn giản, dễ thực hiện, nhắc nhở lịch hẹn, luôn có bản góp ý, thông tin, nhắc nhở động viên tuân thủ, ghi nhận và giải quyết sự góp ý, luôn có sự tham gia của thầy thuốc.

Kết luận

- Khởi phát và tiến triển của bệnh nha chu liên quan với yếu tố tại chỗ, toàn thân, môi trường. Những yếu tố này đều liên quan đến hành vi và cách sống.
- -Xử lý bệnh nha chu không thể chỉ có kỹ thuật, thủ thuật mà còn có những biện pháp kết hợp khác
- -Y bác sĩ phải có trách nhiệm hướng dẫn động viên khích lệ người bệnh thực hiện đúng thường xuyên các biện pháp dự phòng, kỹ năng kiểm soát sau điều trị. Y bác sĩ luôn đặt bệnh nhân ở vị trí trung tâm để phục vụ, phải có kỹ năng giao tiếp tốt. Làm thế nào để thay đổi hành vi chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe là thách thức lớn của người bệnh và thầy thuốc
- -Dự phòng cực kỳ quan trọng ngay cả trong thực hiện kỹ thuật, thủ thuật điều trị bệnh nha chu.



Dự phòng Bệnh ung thư

Số ca/1.000.000 dân/năm

■ 3.15-9.78 ■ 9.79-16.42 ■ 16.43-23.04 ■ 23.05-29.68 ■ 29.69-36.32



Ung thư miệng trên thế giới

**Bảng 2. Tổn thương niêm mạc miệng
ở các tỉnh, thành phía Nam**

Tổn thương	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Ung thư miệng	06	0,06
Bạch sản	342	3,80
Lichen phẳng	37	0,41
Xơ hóa dưới niêm mạc	14	0,15
Hồng sản	02	0,02
Niêm mạc người ăn trầu	154	1,71
Khẩu cái người hút thuốc	119	1,32
Nhiễm nấm Candida	39	0,43
Chốc mép	97	1,07
Viêm miệng do răng giả	221	2,45
Tổn thương khác	616	6,84
Tổng	1.647	19,80

*Nguồn : Ngô Đồng Khanh và CS. Tổn thương tiền ung thư
và ung thư miệng ở miền Nam Việt Nam, 2000*

Bảng 3. Mối liên quan giữa tổn thương tiền ung thư, ung thư miệng và các yếu tố nguy cơ

Yếu tố nguy cơ	Số lượng		Thống kê	P
	Tổn thương	Bình thường		
Hút thuốc			$\chi^2 = 29.94$	
Hút thuốc	196	3669	OR: 1.83	<0.001
Không hút thuốc	146	4989	95% CI: 1,46-2,28	
Uống rượu			$\chi^2 = 29.94$	
Uống rượu	168	2533	OR: 2.33	<0.001
Không uống rượu	174	6125	95% CI: 1,87-2,92	
An trầu			$\chi^2 = 386.95$	
An trầu	58	129	OR: 13.5	<0.001
Không ăn trầu	186	8627	95% CI: 9,56-19,05	

Nguồn: Ngô Đồng Khanh và CS. Tiến ung thư và ung thư miệng ở các tỉnh, thành phía Nam, 2000.⁹

Nguyên nhân chẩn đoán chậm trễ:

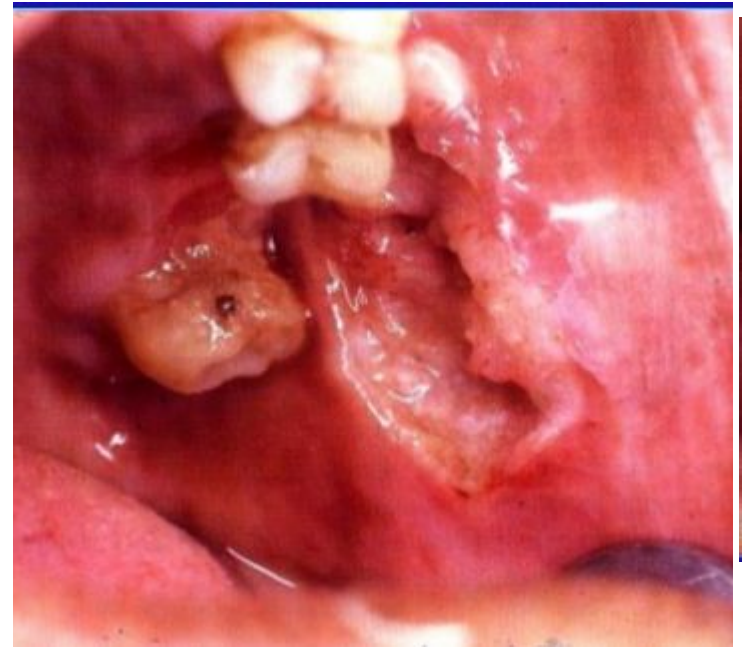
- Chưa được quan tâm đúng mức của thầy thuốc: khám không đầy đủ, không cảnh giác đúng mức, thiếu kiến thức về tổn thương tiền ung thư
- Chưa có chương trình giáo dục phòng bệnh cho cộng đồng, chưa có chương trình tầm soát ung thư cho đối tượng có nguy cơ

Dấu chứng nghi ngờ ung thư hốc miệng

- Loét: không lành sau 02 tuần dù đã loại bỏ kích thích, không xác định được nguyên nhân
- Tổn thương xơ chai, cứng
- Tổn thương sùi
- Tổn thương dính chặt vào mô bên dưới
- Ổ nhỏ răng không lành
- Răng lung lay không rõ nguyên nhân
- Đau, dị cảm không rõ nguyên nhân
- Khó nhai, nói, tăng tiết nước bọt
- Mảng trắng/đỏ
- Hạch cổ

Các loại tổn thương tiền ung thư

- Tổn thương màu trắng: bạch sản...
- Tổn thương màu đỏ: hồng sản...
- Tổn thương lở loét: lupus, viêm loét mạn tính do hàm giả...
- Tổn thương nhiễm sắc



Dự phòng ung thư hốc miệng

- Cấp 0 : Giáo dục sức khỏe để kiểm soát và hạn chế yếu tố nguy cơ
- Cấp 1 : Tầm soát ung thư miệng
- Cấp 2 : điều trị tích cực ngừa di căn
- Cấp 3 : Hạn chế tái phát sau điều trị và làm giảm thương tật do điều trị

A close-up photograph of a pink lotus flower. The petals are covered in numerous small, clear water droplets, giving them a glistening appearance. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting a natural setting. The text "THANK YOU FOR YOUR ATTENTION" is overlaid in the center in a white, bold, sans-serif font.

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION